

Évaluation du risque cardiométabolique chez le diabétique de type 2 : corrélation clinique entre le ratio TG/HDL-c et l'équilibre glycémique

Tabet Aya^{1,2} ; Boukider Nadjet ^{1,23} ; Boutobba Kawther ^{1,2}

¹.Laboratoire de biochimie de CHU Constantine

².Faculte de médecine université de Constantine 3

³.Departement de pharmacie de Constantine

ABSTRACT

Le diabète de type 2 (DT2) est un enjeu majeur de santé publique, associé à un risque accru de complications cardiovasculaires, particulièrement en cas de mauvais équilibre glycémique. Cette étude transversale, menée chez 98 patients DT2 au laboratoire de biochimie du CHU Ibn Badis de Constantine, a évalué le ratio triglycérides/HDL-cholestérol (TG/HDL-c) comme biomarqueur simple et accessible du risque cardiométabolique. Les patients présentant une HbA1c > 7 % avaient un ratio TG/HDL-c plus élevé que ceux dont le diabète était équilibré ($3,52 \pm 2,75$ vs $2,60 \pm 1,35$). Une corrélation positive significative a été observée entre l'HbA1c et le ratio TG/HDL-c ($r = 0,263$; $p = 0,0088$), suggérant que ce ratio constitue un indicateur pertinent, peu coûteux et facilement disponible pour l'évaluation du risque cardiovasculaire et le suivi de la dyslipidémie athérogène chez les patients atteints de DT2.

Introduction

Le diabète de type 2 (DT2) constitue un problème majeur de santé publique en raison de sa prévalence croissante et de ses complications cardiovasculaires. Un mauvais équilibre glycémique favorise la dyslipidémie athérogène et contribue à l'augmentation du risque cardiométabolique. Une HbA1c > 7 % est associée à une majoration du risque cardiovasculaire à long terme.

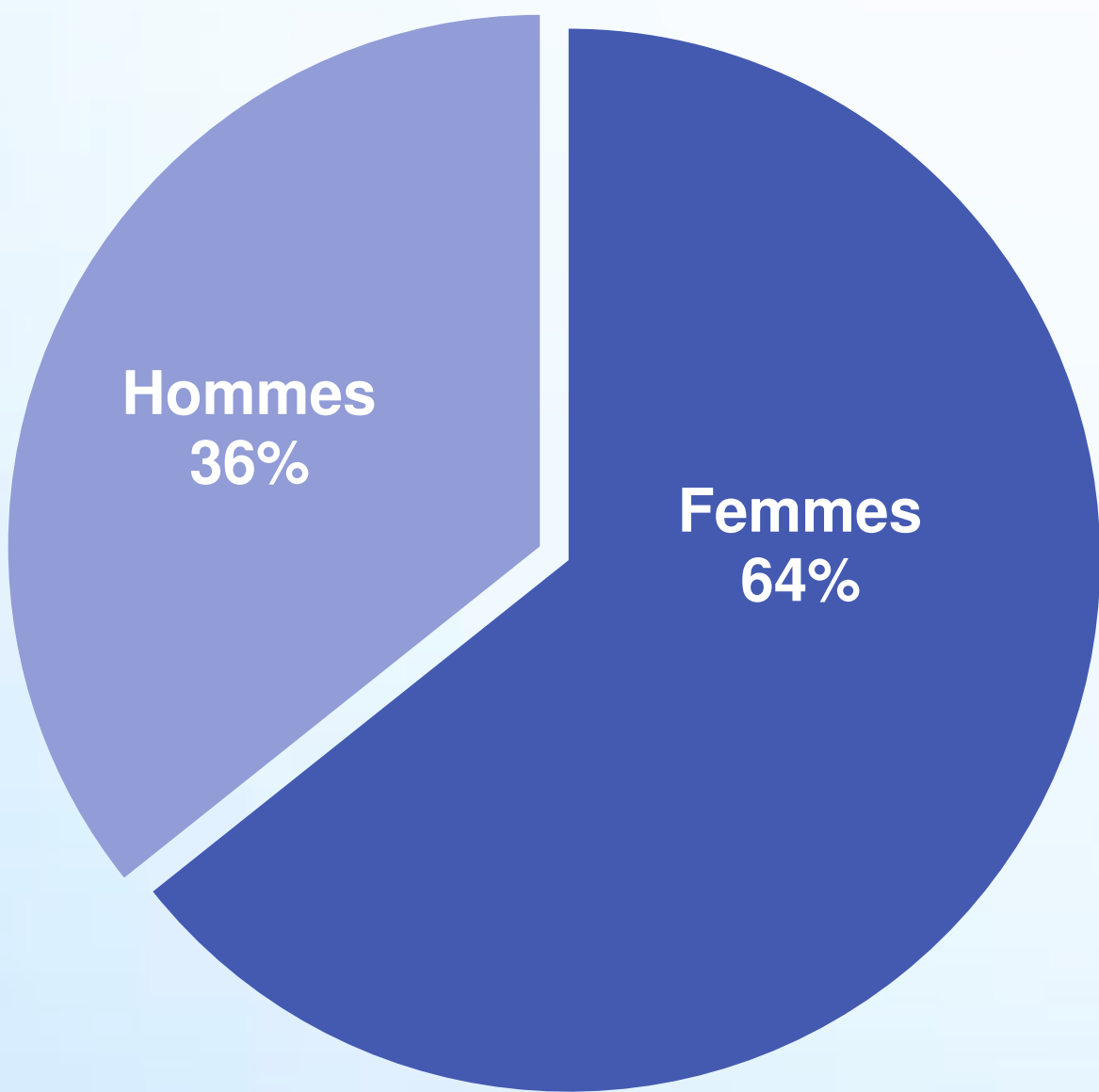
Dans ce contexte, le ratio triglycérides/HDL-cholestérol (TG/HDL-c), biomarqueur simple, accessible et peu coûteux, pourrait constituer un outil pertinent d'évaluation du risque cardiométabolique chez les patients atteints de DT2

Materiels et méthodes

Étude descriptive transversale menée sur une période de **3 mois** au laboratoire de biochimie du CHU Ibn Badis de Constantine, incluant **98 patients** atteints de diabète de type 2 (DT2) âgés de 30 à 80 ans, dont 63 femmes et 35 hommes. Les concentrations sériques des triglycérides (TG) et du HDL-cholestérol (HDL-c) ont été dosées par méthode enzymatique sur l'automate **ARCHITECT ci8200** (Abbott Diagnostics) à partir du bilan lipidique de routine. Le ratio TG/HDL-c a été calculé pour chaque patient. L'HbA1c a été quantifiée par HPLC sur l'automate **D-10**.

Les patients ont été répartis selon l'équilibre glycémique en deux groupes : diabète équilibré (HbA1c < 7 %) et diabète non équilibré (HbA1c ≥ 7 %). L'analyse statistique a été réalisée à l'aide de **Microsoft Excel**, et la relation entre le ratio TG/HDL-c et l'HbA1c a été évaluée par une analyse de corrélation.

Distribution par sexe des patients diabétiques de type 2 inclus dans l'étude



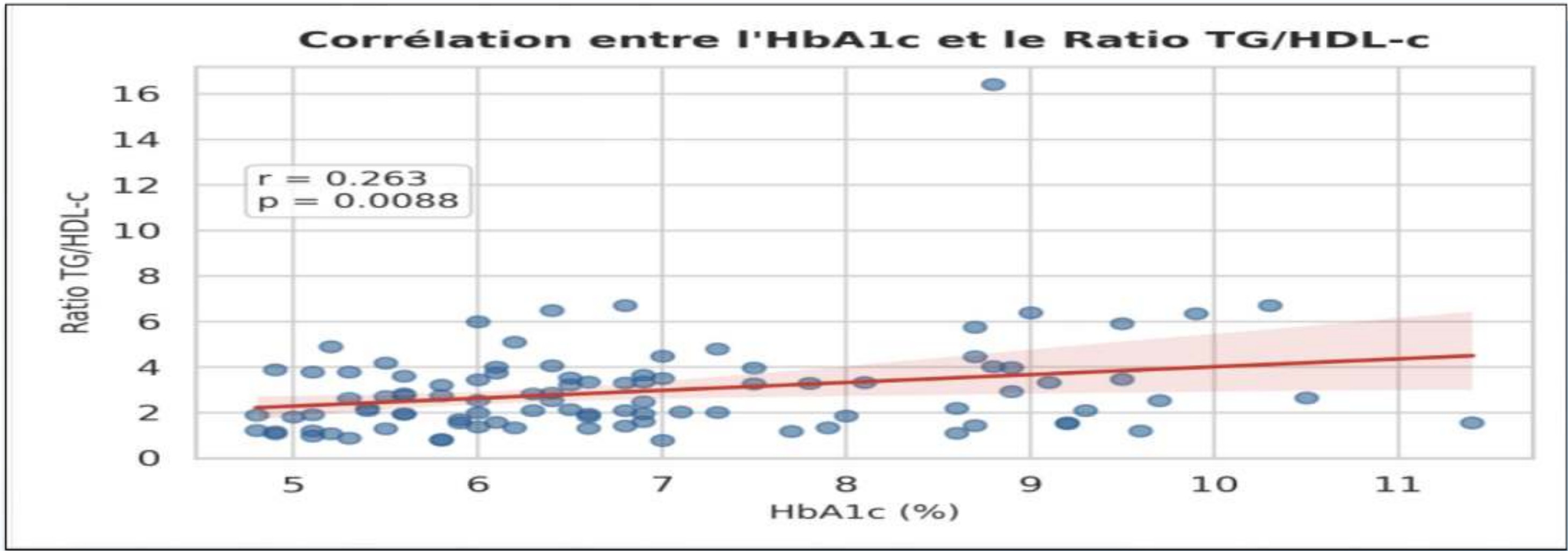
Objectifs

Évaluer la performance du ratio triglycérides/HDL-cholestérol (TG/HDL-c) comme biomarqueur accessible d'évaluation du risque cardiométabolique chez les patients atteints de diabète de type 2, et analyser sa corrélation avec l'équilibre glycémique évalué par l'HbA1c

Résultats et discussion

Chez les 98 patients étudiés, l'HbA1c moyenne était de $6,88 \pm 1,54$ % et le ratio TG/HDL-c de $2,93 \pm 2,02$. Selon l'équilibre glycémique, **64,3 %** des patients présentaient une HbA1c < 7 %, avec un ratio TG/HDL-c moyen de $2,60 \pm 1,35$, contre **35,7 %** ayant une HbA1c ≥ 7 %, chez lesquels le ratio était plus élevé ($3,52 \pm 2,75$). Le nuage de points montre une **tendance linéaire positive** entre l'HbA1c et le ratio TG/HDL-c, avec une corrélation **faible mais statistiquement significative** ($r = 0,263$; $p = 0,0088$). Cette association suggère qu'un moins bon équilibre glycémique s'accompagne globalement d'un profil lipidique plus athérogène.

Sur le plan physiopathologique, l'hyperglycémie et l'insulinorésistance peuvent favoriser l'élévation des TG et la diminution du HDL-c, contribuant ainsi au risque cardiométabolique.



Conclusion

Le ratio TG/HDL-c pourrait constituer un **marqueur simple et accessible du profil cardiométabolique** chez les patients atteints de DT2. Toutefois, la faible intensité de la corrélation observée et le caractère transversal de l'étude ne permettent pas d'établir une relation causale ni de prédire directement la survenue d'événements cardiovasculaires